

过敏（过敏性疾病）医学知识全解析

一、疾病定义与分类

过敏，医学上称为“过敏性疾病”或“变态反应性疾病”，是指机体接触特定过敏原后，免疫系统过度激活（异常免疫应答），对自身无害的物质产生病理性反应，导致组织损伤或功能紊乱的一类疾病。其核心机制是免疫系统将过敏原误判为“有害物质”，启动免疫反应攻击过敏原，同时损伤周围正常组织，临床表现多样，从轻症的皮肤瘙痒、打喷嚏，到重症的过敏性休克（危及生命），严重影响患者生活质量。

根据国际变态反应学会（WAO）的分类标准，结合过敏原接触途径与发病部位，过敏性疾病主要分为以下几类：

呼吸道过敏性疾病：过敏原通过呼吸道吸入引发，常见类型包括过敏性鼻炎（变应性鼻炎）与过敏性哮喘。过敏性鼻炎表现为鼻痒、打喷嚏、清水样流涕、鼻塞，多在接触花粉、尘螨、动物皮屑后发作；过敏性哮喘以气道高反应性为特征，表现为反复发作的喘息、胸闷、咳嗽，夜间或清晨发作加重，过敏原刺激后气道平滑肌痉挛，导致呼吸困难。

皮肤过敏性疾病：过敏原通过皮肤接触或口服、吸入后引发皮肤反应，常见类型包括荨麻疹（风团）、特应性皮炎（湿疹）、接触性皮炎。荨麻疹表现为皮肤突发风团（红色或苍白色隆起），伴剧烈瘙痒，风团数小时内消退但易反复发作；特应性皮炎多见于婴幼儿，表现为皮肤干燥、红斑、丘疹、渗出，伴长期瘙痒，常伴随过敏性鼻炎、哮喘等其他过敏性疾病（“特应性三联征”）；接触性皮炎是皮肤接触过敏原（如化妆品、金属镍、染发剂）后局部出现红斑、水疱、瘙痒，边界与接触范围一致。

食物过敏性疾病：摄入含过敏原的食物后引发，分为 IgE 介导型与非 IgE 介导型。IgE 介导型起病急（进食后数分钟至 1 小时），表现为口腔瘙痒（口腔过敏综合征）、呕吐、腹泻、荨麻疹，严重者出现喉头水肿、过敏性休克；非 IgE 介导型起病慢（进食后数小时至数天），表现为食物蛋白诱导性小肠结肠炎综合征（呕吐、腹胀、便血）、特应性皮炎加重，儿童多见。常见致敏食物包括牛奶、鸡蛋、花生、坚果、海鲜（虾、蟹）、大豆、小麦。

药物过敏性疾病：使用药物后引发的过敏反应，常见致敏药物包括青霉素类、头孢菌素类抗生素，阿司匹林、布洛芬等非甾体抗炎药，以及抗癫痫药（如苯巴比妥）、疫苗等。临床表现多样，从轻症的药物疹（斑丘疹、荨麻疹），到重症的药物超敏反应综合征（伴发热、淋巴肿大、肝肾功能损伤）、过敏性休克，部分药物（如阿司匹林）还可能诱发哮喘发作（阿司匹林哮喘）。

其他过敏性疾病：包括过敏性结膜炎（眼痒、结膜充血、流泪，过敏原多为花粉、尘螨）、过敏性休克（最严重的过敏反应，全身多系统受累，表现为血压骤降、呼吸困难、意识障碍，需立即抢救）、昆虫毒液过敏（被蜂、黄蜂、火蚁叮咬后出现局部肿胀、荨麻疹，严重者引发过敏性休克）。

二、病理生理机制

过敏的病理生理机制核心是“免疫系统异常激活”，主要涉及 IgE 介导的 I 型变态反应（速发型变态反应），部分疾病（如接触性皮炎）涉及 IV 型变态反应（迟发型变态反应），具体过程可分为“致敏阶段”与“效应阶段”，同时与机体遗传易感性、免疫调节紊乱密切相关。

（一）I 型变态反应机制（占过敏性疾病的 80% 以上）

致敏阶段：首次接触过敏原后，机体免疫系统将其识别为“外来异物”，激活 B 淋巴细胞并分化为浆细胞，产生特异性 IgE 抗体。IgE 抗体的 Fc 段与肥大细胞、嗜碱性粒细胞表面的 $Fc\epsilon RI$ 受体结合，使机体处于“致敏状态”，此阶段无临床症状，持续时间可从数天至数年（若未再次接触过敏原，致敏状态可逐渐消退）。常见的致敏原包括花粉（如桦树花粉、豚草花粉）、尘螨（屋尘螨、粉尘螨）、动物皮屑（猫毛、狗毛）、食物蛋白（牛

奶酪蛋白、鸡蛋卵清蛋白)、昆虫毒液(蜂毒)。

效应阶段:再次接触相同过敏原时,过敏原与肥大细胞、嗜碱性粒细胞表面的特异性 IgE 抗体 Fab 段结合,导致 IgE 交联聚集,激活细胞内信号通路,促使肥大细胞、嗜碱性粒细胞脱颗粒,释放大量的生物活性介质。主要介质包括组胺(引起血管扩张、通透性增加,导致皮肤风团、鼻黏膜水肿、支气管痉挛)、白三烯(加重气道炎症,导致哮喘持续发作、血管收缩)、前列腺素(增强血管扩张与疼痛感受,加重炎症反应)、细胞因子(如 IL-4、IL-5,促进 Th2 型免疫反应,维持过敏状态)。这些介质作用于不同靶器官,引发相应症状:作用于鼻部黏膜,导致鼻痒、打喷嚏、流涕;作用于气道,导致支气管痉挛、哮喘;作用于皮肤,导致荨麻疹、瘙痒;作用于全身血管,导致血管扩张、血压下降,引发过敏性休克。

(二) IV 型变态反应机制(迟发型,如接触性皮炎)

与 I 型变态反应不同,IV 型变态反应不依赖 IgE,而是由 T 淋巴细胞介导,起病慢(接触过敏原后 24-72 小时发作)。具体过程为:过敏原(如化妆品中的防腐剂、金属镍)进入皮肤后,被表皮朗格汉斯细胞吞噬并加工处理,形成“过敏原-MHC II 类分子复合物”,呈递给 CD4⁺ T 淋巴细胞(Th1 细胞),激活 Th1 细胞并使其分化为效应 T 细胞。效应 T 细胞通过血液循环迁移至皮肤接触部位,释放干扰素- γ 、肿瘤坏死因子- α 等细胞因子,招募单核细胞、巨噬细胞等炎症细胞聚集,引发局部炎症反应,表现为皮肤红斑、丘疹、水疱、瘙痒,炎症持续时间较长(若持续接触过敏原,症状可加重或迁延)。

(三) 遗传与免疫调节因素

过敏性疾病具有明显遗传倾向,若父母一方患有过敏性疾病,子女患病风险为 30%-50%;父母双方均患病,子女风险升至 60%-80%。相关基因(如 IL-4 基因、Fc ϵ RI 基因)突变可能导致机体 Th2 型免疫反应增强(Th2 细胞分泌 IL-4、IL-5,促进 IgE 生成),或皮肤、黏膜屏障功能异常(如特应性皮炎患者皮肤角质层脂质合成减少,过敏原易穿透皮肤)。此外,环境因素(如婴幼儿时期过度清洁、空气污染、肠道菌群失调)也会影响免疫发育,导致免疫系统失衡,增加过敏风险(“卫生假说”)。

三、临床表现

过敏性疾病的临床表现因疾病类型、过敏原种类、个体差异而异,从轻症的局部症状到重症的全身反应,症状发作时间也分为速发型(数分钟至 1 小时)与迟发型(数小时至数天),具体表现如下:

(一) 呼吸道过敏性疾病表现

过敏性鼻炎:典型症状为“四大症状”——鼻痒(频繁揉鼻、挖鼻)、阵发性喷嚏(每次 3-5 个,甚至更多)、清水样流涕(量多,需频繁擦拭)、鼻塞(单侧或双侧,夜间加重,影响睡眠)。部分患者伴随眼痒、结膜充血(过敏性结膜炎表现),长期鼻塞可导致张口呼吸、打鼾,儿童长期患病可能出现“腺样体面容”(上颌骨变长、牙齿排列不齐)。症状发作具有季节性(如春季花粉过敏)或常年性(如尘螨、动物皮屑过敏),接触过敏原后数分钟内发作,脱离过敏原后数小时至 1 天内缓解。

过敏性哮喘:核心症状为反复发作的喘息(呼气时发出“喉鸣样”声音)、胸闷(胸部压迫感,活动后加重)、咳嗽(多为干咳或少量白色黏液痰,夜间或清晨发作频繁),严重发作时出现呼吸困难(呼吸急促、鼻翼扇动、三凹征——胸骨上窝、锁骨上窝、肋间隙凹陷),口唇发绀。哮喘发作分为急性发作期(症状突然加重,需紧急用药)、慢性持续期(每周发作 1-2 次,日常活动受轻度影响)、临床缓解期(症状消失,肺功能正常,维持 3 个月以上)。部分患者(尤其儿童)仅表现为咳嗽(咳嗽变异性哮喘),无明显喘息,易被误诊为“支气管炎”。

(二) 皮肤过敏性疾病表现

荨麻疹:典型表现为皮肤突发风团,风团呈圆形、椭圆形或不规则形,颜色为红色或苍白色,

大小不一（从米粒至手掌大），边界清晰，伴剧烈瘙痒。风团出现后数分钟至数小时内自行消退，不留痕迹，但易反复发作（此起彼伏），若风团持续超过 24 小时不消退，且伴随疼痛（非瘙痒），需警惕“血管性水肿型荨麻疹”或“荨麻疹性血管炎”。严重者可出现全身症状，如发热、乏力、腹痛、呼吸困难，甚至过敏性休克。

特应性皮炎（湿疹）：不同年龄段表现不同。婴幼儿期（0-2 岁）：好发于面颊、额部、头皮，表现为皮肤干燥、红斑、丘疹、水疱，水疱破裂后出现渗出、结痂，伴剧烈瘙痒，患儿因瘙痒频繁哭闹、搔抓，导致皮肤破损继发感染（如脓疱疮）；儿童期（2-12 岁）：好发于肘窝、腘窝（“四弯风”），表现为皮肤增厚、苔藓样变（皮肤粗糙、纹理加深），瘙痒明显，夜间加重影响睡眠；成年期（>12 岁）：好发于颈部、眼睑、四肢屈侧，表现为干燥性红斑、丘疹，伴随皮肤瘙痒、脱屑，常合并过敏性鼻炎、哮喘。

接触性皮炎：症状局限于皮肤接触过敏原的部位，边界清晰，与接触物形态一致（如戴手表处出现环形红斑）。轻度表现为局部红斑、丘疹，伴瘙痒；中度表现为水疱、渗出，水疱破裂后形成糜烂、结痂；重度表现为皮肤坏死、溃疡，伴疼痛。症状在接触过敏原后 24-72 小时出现（迟发型），脱离接触后，轻度患者 1-2 周内自愈，重度患者需治疗后数周恢复，若反复接触过敏原，可转为慢性接触性皮炎（皮肤增厚、苔藓样变）。

（三）食物过敏性疾病表现

IgE 介导型（速发型）：进食致敏食物后数分钟至 1 小时内发作，症状涉及多系统。口腔：口腔黏膜瘙痒、肿胀（口腔过敏综合征，常见于对花粉过敏者进食水果时，如“桦树花粉-苹果综合征”）；皮肤：荨麻疹、血管性水肿（眼睑、口唇肿胀）；消化道：呕吐、腹痛、腹泻（水样便或黏液便）；呼吸道：喉头水肿（声音嘶哑、呼吸困难）、哮喘发作；全身：过敏性休克（血压骤降、意识模糊、四肢湿冷），是最严重的表现，需立即抢救。

非 IgE 介导型（迟发型）：进食后数小时至数天发作，症状以消化道或皮肤为主。食物蛋白诱导性小肠结肠炎综合征（多见于婴幼儿）：表现为呕吐、腹胀、腹泻，严重者出现脱水、体重下降；食物蛋白诱导性直肠结肠炎（婴幼儿）：表现为大便带血（血丝或黏液血便），无发热、呕吐；特应性皮炎加重：进食致敏食物（如牛奶、鸡蛋）后，特应性皮炎症状明显加重，瘙痒加剧，皮肤红斑范围扩大。

（四）药物过敏性疾病表现

轻症药物疹：最常见类型为斑丘疹型药疹，表现为全身散在红色斑丘疹，伴瘙痒，无发热或低热，停药后 1-2 周内消退；荨麻疹型药疹表现为皮肤风团，与普通荨麻疹类似，但瘙痒更剧烈，持续时间更长，部分患者伴随血管性水肿。

重症药物过敏反应：包括药物超敏反应综合征（伴发热、淋巴结肿大、肝肾功能损伤，皮疹为广泛性红斑，可累及黏膜）、Stevens-Johnson 综合征（重症多形红斑型药疹，表现为广泛水疱、皮肤剥脱，累及口腔、眼、生殖器黏膜，伴高热、感染风险）、过敏性休克（青霉素类药物最易引发，用药后数分钟内出现血压下降、呼吸困难、喉头水肿，死亡率高）。

（五）过敏性休克表现（全身重症反应）

过敏性休克是最严重的过敏性疾病，属于 I 型变态反应的全身表现，起病急（接触过敏原后数分钟至 1 小时内），进展迅速。早期表现为皮肤症状（荨麻疹、血管性水肿、皮肤瘙痒），随后迅速出现全身症状：循环系统（血压骤降，收缩压 < 90mmHg，伴四肢湿冷、皮肤花斑、脉搏细速）；呼吸系统（喉头水肿导致声音嘶哑、呼吸困难、窒息感，支气管痉挛引发哮喘样发作）；神经系统（意识障碍，从烦躁不安、嗜睡至昏迷）；消化系统（恶心、呕吐、腹痛、腹泻）。若未及时抢救，患者可在 10-30 分钟内死于呼吸衰竭或循环衰竭，是临床需优先处理的急危重症。

四、诊断与鉴别诊断

过敏性疾病的诊断需遵循“病史采集为基础，辅助检查为依据”的原则，结合临床表现明

明确过敏原与疾病类型，同时排除相似疾病，避免误诊或漏诊。

（一）病史采集（核心环节）

详细的病史采集可初步判断过敏类型与可疑过敏原，需重点关注以下信息：

症状特点：记录症状发作时间（速发或迟发）、持续时间、具体表现（如皮疹形态、呼吸道症状）、缓解因素（脱离某环境或停用某食物 / 药物后症状是否缓解），例如：春季发作的鼻痒、打喷嚏，提示花粉过敏；进食海鲜后出现荨麻疹，提示食物过敏；使用青霉素后出现休克，提示药物过敏。

过敏原接触史：详细询问近期接触的物质，包括吸入物（花粉、尘螨、动物皮屑、香水）、食物（牛奶、鸡蛋、花生、海鲜、坚果）、药物（抗生素、非甾体抗炎药、疫苗）、接触物（化妆品、金属、衣物材质）、昆虫叮咬史（蜂、火蚁），同时记录接触与症状发作的时间关联（如接触后数分钟发作，提示 IgE 介导型过敏）。

既往史与家族史：询问是否曾患过敏性疾病（如过敏性鼻炎、哮喘），是否有药物或食物过敏史；询问家族成员（父母、兄弟姐妹）是否有过敏性疾病，明确遗传倾向，有助于判断“特应性体质”（如特应性皮炎患者多有家族过敏史）。

治疗反应史：询问使用抗过敏药物（如氯雷他定、糖皮质激素）后的效果，例如：使用抗组胺药后荨麻疹消退，支持过敏诊断；使用抗生素后症状无改善，排除感染性疾病。

（二）体格检查（定位病变与评估严重程度）

体格检查需针对症状涉及的系统，重点关注以下体征：

皮肤检查：观察皮疹类型（风团、红斑、丘疹、水疱）、分布范围（局限或全身）、是否伴随渗出、结痂、苔藓样变，例如：荨麻疹可见散在风团，接触性皮炎皮疹局限于接触部位，特应性皮炎可见皮肤干燥、屈侧红斑。

呼吸道检查：过敏性鼻炎患者可见鼻黏膜苍白水肿、鼻腔内清水样分泌物；过敏性哮喘患者听诊肺部可闻及呼气相哮鸣音（呼气时明显），严重发作时出现三凹征、口唇发绀。

眼部检查：过敏性结膜炎患者可见结膜充血、眼睑水肿、眼部分泌物增多（清水样），伴眼痒。

全身检查：评估生命体征（血压、心率、呼吸、体温），过敏性休克患者可见血压下降、心率加快、呼吸急促；药物超敏反应综合征患者可见淋巴结肿大、肝脾肿大（提示全身受累）。

（三）辅助检查（明确过敏原与过敏类型）

过敏原检测：皮肤点刺试验：最常用的 IgE 介导型过敏检测方法，将少量纯化过敏原提取物滴于皮肤，用特制针头轻刺皮肤（不出血），15-20 分钟后观察结果。若出现风团（直径 > 3mm）伴红晕，提示对该过敏原过敏，适用于检测吸入性过敏原（花粉、尘螨）、食物过敏原（牛奶、鸡蛋）、昆虫毒液过敏原。优点是快速、简便、费用低，缺点是皮肤严重破损（如特应性皮炎急性期）或使用抗组胺药者不宜进行，可能出现假阳性或假阴性。血清特异性 IgE 检测（sIgE）：通过血液检测针对某一过敏原的特异性 IgE 抗体水平，适用于皮肤点刺试验禁忌者（如严重皮肤疾病、正在使用抗组胺药）、婴幼儿、过敏性休克高危人群。检测结果以“等级”表示（0-6 级），等级越高，过敏可能性越大，可检测吸入性、食物、药物过敏原，但费用较高，且仅能检测 IgE 介导型过敏，非 IgE 介导型过敏（如食物蛋白诱导性小肠结肠炎）检测结果阴性。食物激发试验：诊断食物过敏的“金标准”，在医生监护下，让患者逐渐摄入可疑致敏食物（从极少量开始，逐渐增加剂量），观察是否出现过敏症状。适用于血清 sIgE 阳性但临床症状不明确，或需排除假阳性的患者，需在具备急救条件的医院进行（防止过敏性休克），禁忌证包括严重食物过敏史、过敏性休克史。斑贴试验：诊断接触性皮炎的核心检查，将含可疑过敏原的贴片（如化妆品成分、金属镍、染料、防腐剂等）贴于背部健康皮肤，用胶带固定，保持 48 小时后取下，分别在取下后 30 分钟、24 小时、48 小时观察皮肤反应。若贴敷部位出现红斑、丘疹、水疱，提示对该过

敏原过敏，反应强度按“+”（轻微红斑）至“++++”（水疱、糜烂）分级。该检查适用于迟发型变态反应（如接触性皮炎），优点是可检测多种接触性过敏原，缺点是不适用于 IgE 介导的速发型过敏，且贴敷期间需避免洗澡、剧烈运动，防止贴片脱落或汗液影响结果。此外，针对特定过敏性疾病还需进行针对性检查：过敏性哮喘患者需行肺功能检查，包括通气功能检查（如 FEV1/FVC，哮喘发作时 FEV1/FVC < 70%）与支气管舒张试验（吸入沙丁胺醇后 FEV1 改善 ≥ 12%，提示气道高反应性），严重者需行呼气一氧化氮（FeNO）检测，FeNO 升高（> 25ppb）提示气道炎症；特应性皮炎患者可检测外周血嗜酸性粒细胞计数（常升高，> 5%）与总 IgE 水平（多显著升高），评估炎症严重程度；药物过敏患者若怀疑重症药疹（如 Stevens-Johnson 综合征），需行肝肾功能、血常规检查，可见转氨酶升高（肝功能损伤）、白细胞计数异常（如白细胞减少或升高）；过敏性休克患者需紧急检测血压、心率、血氧饱和度，同时行血气分析（评估呼吸衰竭）、电解质检查（排除脱水导致的电解质紊乱），指导急救用药。

（四）鉴别诊断（排除相似疾病，明确过敏类型）

过敏性疾病需与多种非过敏性疾病鉴别，避免因症状相似导致误诊，核心鉴别要点如下：

1. 呼吸道过敏性疾病的鉴别

过敏性鼻炎需与普通感冒鉴别：普通感冒多由病毒感染引起，伴随咽痛、咳嗽、低热等全身症状，鼻涕初期清水样，后期变黏稠，病程 7-10 天自愈；过敏性鼻炎无全身症状，鼻涕持续清水样，伴鼻痒、阵发性喷嚏，症状与接触过敏原相关，病程可长达数周或数月，抗组胺药治疗有效。

过敏性哮喘需与慢性支气管炎鉴别：慢性支气管炎多见于长期吸烟的中老年人，表现为每年咳嗽、咳痰 ≥ 3 个月，持续 2 年以上，无明显过敏原接触史，肺功能检查可见 FEV1 进行性下降（不可逆气流受限）；过敏性哮喘多见于青少年，症状与过敏原接触相关，发作时伴喘息、胸闷，肺功能检查支气管舒张试验阳性（可逆气流受限），抗哮喘药物（如吸入性糖皮质激素）治疗有效。

2. 皮肤过敏性疾病的鉴别

荨麻疹需与丘疹性荨麻疹鉴别：丘疹性荨麻疹多由蚊虫叮咬引起，表现为纺锤形红色丘疹，顶端可有水疱，伴瘙痒，皮疹持续数天至 1 周消退，遗留色素沉着；荨麻疹表现为风团，数小时内消退不留痕迹，反复发作，无蚊虫叮咬史，抗组胺药治疗快速缓解。

特应性皮炎需与脂溢性皮炎鉴别：脂溢性皮炎好发于头皮、眉弓、胸背部等皮脂腺丰富部位，表现为红斑、油腻性鳞屑，瘙痒较轻，与皮脂腺分泌旺盛相关，多见于成人；特应性皮炎好发于四肢屈侧，表现为皮肤干燥、红斑、丘疹，伴剧烈瘙痒，多伴随过敏性鼻炎、哮喘等特应性疾病，婴幼儿多见。

接触性皮炎需与湿疹鉴别：湿疹病因复杂（如环境、遗传、感染），皮疹多对称分布，边界不清，无明确接触史，病程长易复发；接触性皮炎皮疹局限于接触部位，边界清晰，与接触过敏原（如化妆品、金属）直接相关，脱离接触后经治疗可较快痊愈，再次接触可复发。

3. 食物过敏性疾病的鉴别

食物过敏需与食物不耐受鉴别：食物不耐受（如乳糖不耐受、果糖不耐受）是因机体缺乏消化酶（如乳糖酶）导致食物消化吸收障碍，表现为腹胀、腹泻、腹痛，无皮肤瘙痒、荨麻疹等过敏症状，症状多在进食后数小时出现，与进食量相关（少量进食可能无症状），停止进食后症状缓解，无免疫机制参与；食物过敏是免疫介导的病理性反应，可出现皮肤、呼吸道、全身症状（如荨麻疹、哮喘、休克），症状与进食量无绝对关联（少量进食即可诱发），抗组胺药或糖皮质激素治疗有效。

4. 药物过敏性疾病的鉴别

药物过敏需与药物不良反应鉴别：药物不良反应是药物本身的药理作用或毒性作用导致，如

阿司匹林引起的胃肠道不适、降压药引起的头晕，无免疫机制参与，症状与用药剂量相关（剂量越大症状越重），停药后症状逐渐缓解，所有使用该药物的人群均可能出现；药物过敏是免疫介导的特异性反应，与用药剂量无关（小剂量即可诱发），表现为皮疹、瘙痒、休克等过敏症状，仅少数过敏体质人群出现，停药后需使用抗过敏药物治疗缓解。

此外，还需鉴别过敏性休克与其他休克类型（如感染性休克、心源性休克）：过敏性休克有明确过敏原接触史（如用药、昆虫叮咬），起病前多有皮肤瘙痒、荨麻疹等前驱症状，休克发生迅速（接触后数分钟至 1 小时）；感染性休克有感染证据（如高热、白细胞升高），起病前有感染症状（如咳嗽、尿痛）；心源性休克有心脏基础疾病（如心肌梗死、心力衰竭），起病前有胸痛、呼吸困难等症状，通过病史与辅助检查（如血常规、心电图）可明确鉴别。

五、治疗方案

过敏性疾病的治疗需遵循“规避过敏原为基础、对症治疗为核心、重症急救为重点”的原则，结合疾病类型、严重程度及患者个体差异制定方案，同时参考《过敏性疾病诊疗指南（2024 年版）》等最新共识，确保治疗的安全性与有效性。

（一）基础治疗：规避过敏原

规避已知或可疑过敏原是所有过敏性疾病的首要治疗措施，可从源头减少过敏发作频率与严重程度。呼吸道过敏性疾病患者，需根据过敏原类型采取针对性措施：对花粉过敏者，春季（树木花粉）、秋季（杂草花粉）高发期减少户外活动，外出时佩戴 N95 口罩与防风镜，回家后及时清洗头发、衣物；对尘螨过敏者，定期用 55℃ 以上热水清洗床单、被套（每周 1 次），使用防螨床垫、枕套，减少室内地毯、毛绒玩具等易积尘物品；对动物皮屑过敏者，避免饲养猫、狗等宠物，若已饲养需定期给宠物洗澡、梳理毛发，保持室内通风。

皮肤过敏性疾病患者，接触性皮炎需明确并避免接触致敏物（如含镍饰品、某类化妆品防腐剂），更换为无刺激的替代产品；特应性皮炎患者需选择纯棉、宽松衣物，避免羊毛、化纤材质直接接触皮肤，洗澡水温控制在 32-37℃，避免过度清洁导致皮肤屏障破坏。食物过敏性疾病患者，需严格禁食已明确的致敏食物（如牛奶过敏者避免牛奶及含乳食品，花生过敏者避免花生及花生制品），购买包装食品时仔细阅读成分表，避免误食含致敏成分的加工食品；口腔过敏综合征患者（如对桦树花粉过敏者）需避免食用交叉反应性水果（如苹果、梨），或通过加热（如蒸熟）破坏水果中的致敏蛋白后少量尝试。

药物过敏性疾病患者，需终身禁用已明确的致敏药物（如青霉素过敏者禁用所有青霉素类药物），就医时主动告知过敏史，避免医生开具同类致敏药物；若因病情需使用与致敏药物结构相似的药物（如头孢菌素类与青霉素类），需在医生监护下进行皮肤试验，阴性后方可使用，并密切观察 30 分钟以上。昆虫毒液过敏患者，户外活动时穿长袖衣物、长裤，避免穿鲜艳衣物或使用芳香类护肤品（吸引蜂类），若遇蜂群需缓慢离开，避免拍打引发攻击。

（二）对症治疗：缓解症状，控制炎症

1. 抗组胺药：适用于轻中度过敏反应

抗组胺药通过阻断组胺 H1 受体，缓解皮肤瘙痒、荨麻疹、鼻痒、打喷嚏等症状，是过敏性疾病的一线用药。根据作用机制与起效时间，分为第一代与第二代：第一代抗组胺药（如氯苯那敏、赛庚啶）起效快（30 分钟内），但易通过血脑屏障引发嗜睡、口干，适合夜间服用或短期使用（如过敏急性发作时），驾驶员、高空作业者禁用；第二代抗组胺药（如氯雷他定、西替利嗪、依巴斯汀）嗜睡副作用弱，每日服用 1 次即可维持 24 小时疗效，适合白天服用，且对儿童、老年人耐受性较好，是临床首选。

不同疾病的用药方案略有差异：过敏性鼻炎患者可联合使用抗组胺药鼻喷剂（如氮卓斯汀鼻喷剂），局部用药起效更快，减少全身副作用；荨麻疹患者若常规剂量治疗效果不佳，可在医生指导下加倍剂量（如氯雷他定从 10mg / 日增至 20mg / 日），或联合两种不同作用机制的抗组胺药；特应性皮炎患者可使用抗组胺药缓解瘙痒（尤其夜间瘙痒影响睡眠时），

但需配合外用药物修复皮肤屏障。需注意，抗组胺药对非 IgE 介导的过敏反应（如食物蛋白诱导性小肠结肠炎）效果不佳，不可盲目使用。

2. 糖皮质激素：适用于中重度炎症反应

糖皮质激素具有强大的抗炎、抗过敏作用，适用于抗组胺药治疗无效的中重度过敏反应，或炎症累及多系统的情况。根据病情严重程度，分为局部用药与全身用药：局部用药（如外用糖皮质激素乳膏、吸入性糖皮质激素、鼻用糖皮质激素）副作用小，是临床常用方式，如特应性皮炎患者根据皮损严重程度选择不同强度的外用乳膏（轻度用弱效激素如氢化可的松乳膏，中度用中效激素如丁酸氢化可的松乳膏，重度用强效激素如糠酸莫米松乳膏），连续使用不超过 2 周，避免长期使用导致皮肤萎缩；过敏性鼻炎患者使用鼻用糖皮质激素（如布地奈德鼻喷剂），可减轻鼻黏膜水肿，改善鼻塞症状，需规律使用 1-2 周后评估疗效；过敏性哮喘患者吸入糖皮质激素（如布地奈德福莫特罗粉吸入剂），可控制气道慢性炎症，减少哮喘发作频率。

全身用药（如口服泼尼松、静脉注射甲泼尼龙）仅用于重症患者，如重症药物疹（Stevens-Johnson 综合征）、严重过敏性哮喘急性发作、过敏性休克抢救后，需严格遵医嘱使用，避免自行增减剂量。口服泼尼松常规剂量为每日 10-30mg，晨起顿服，病情控制后逐渐减量（如每周减 5mg），避免突然停药引发肾上腺皮质功能不全；静脉注射甲泼尼龙用于紧急情况，剂量为每日 40-80mg，待症状缓解后转为口服治疗。长期使用全身糖皮质激素需监测副作用，如血糖升高、血压升高、骨质疏松，必要时补充钙剂（如碳酸钙）与维生素 D。

3. 支气管扩张剂：适用于过敏性哮喘

支气管扩张剂通过松弛气道平滑肌，缓解哮喘发作时的喘息、呼吸困难症状，分为短效与长效：短效 β_2 受体激动剂（如沙丁胺醇气雾剂）起效快（5-10 分钟），作用持续 4-6 小时，适用于哮喘急性发作，每次 1-2 喷，20 分钟内可重复 1 次，每日使用不超过 8 喷；长效 β_2 受体激动剂（如沙美特罗）作用持续 12 小时，需与吸入性糖皮质激素联合使用（如沙美特罗替卡松粉吸入剂），用于哮喘慢性持续期维持治疗，每日 2 次，每次 1 吸，不可单独使用（避免掩盖气道炎症）。

对于严重哮喘发作患者，可联合使用抗胆碱能药物（如异丙托溴铵气雾剂），与 β_2 受体激动剂协同扩张气道，每次 2 喷，每日 3-4 次；若常规药物治疗效果不佳，需静脉使用氨茶碱（负荷剂量 4-6mg/kg，缓慢静脉注射，随后以 0.5-0.8mg/kg/h 维持），但需监测血药浓度（避免中毒），老年人、肝肾功能不全者需调整剂量。

4. 其他对症药物

白三烯调节剂（如孟鲁司特钠）：通过阻断白三烯介导的炎症反应，适用于过敏性鼻炎与哮喘的联合治疗，尤其适合对阿司匹林过敏的哮喘患者，每日 1 次，睡前服用，儿童需根据年龄选择剂量（2-5 岁 4mg / 次，6-14 岁 5mg / 次，15 岁以上 10mg / 次）。

肥大细胞稳定剂（如色甘酸钠）：通过稳定肥大细胞膜，减少介质释放，适用于过敏性鼻炎、过敏性结膜炎的预防治疗，如色甘酸钠滴鼻剂每日 4 次，每次 1-2 滴，色甘酸钠滴眼液每日 4 次，每次 1-2 滴，起效慢（需连续使用 1-2 周），适合轻症患者或过敏高发期预防使用。

免疫球蛋白：仅用于严重过敏反应（如难治性特应性皮炎、重症过敏性休克），通过调节免疫系统减轻炎症，静脉输注剂量为每日 400-800mg/kg，连续使用 3-5 天，费用较高，需严格掌握适应证。

（三）重症急救：过敏性休克的抢救

过敏性休克是最严重的过敏反应，需立即启动急救流程，遵循“快速、规范”原则，抢救措施如下：

立即脱离过敏原：停止使用致敏药物、食物，若为昆虫叮咬需远离叮咬环境，避免继续接触引发症状加重。

保持呼吸道通畅：让患者平卧，头偏向一侧，抬起下颌，清除口腔分泌物，若出现喉头水肿导致呼吸困难，需立即行气管插管或气管切开（由专业医护人员操作），必要时给予吸氧（5-10L/min），维持血氧饱和度 > 95%。

注射肾上腺素：肾上腺素是过敏性休克的首选抢救药物，通过收缩血管、升高血压、松弛支气管平滑肌，缓解休克症状。成人剂量为 0.3-0.5mg，皮下或肌肉注射，儿童剂量为 0.01mg/kg（最大剂量 0.3mg），若症状未缓解，可每 5-10 分钟重复注射 1 次，直至休克纠正；若患者出现心跳呼吸骤停，需立即静脉注射肾上腺素（1mg，稀释后缓慢注射），同时进行心肺复苏。

补充血容量：快速静脉输注生理盐水或平衡液（如林格氏液），初始剂量为成人 500-1000mL，儿童 20mL/kg，在 30 分钟内输注完毕，改善组织灌注，纠正低血压（目标收缩压 $\geq$ 90mmHg），必要时使用血管活性药物（如去甲肾上腺素）维持血压。

其他急救药物：静脉注射糖皮质激素（如甲泼尼龙 40-80mg）减轻炎症反应，静脉注射抗组胺药（如苯海拉明 20-40mg）缓解皮肤症状，若支气管痉挛严重，可雾化吸入沙丁胺醇溶液（5mg 稀释后雾化）。

监测生命体征：抢救期间持续监测血压、心率、呼吸、血氧饱和度、心电图，记录尿量（评估循环灌注），待病情稳定后转入 ICU 继续观察 24-48 小时，避免症状反复。

六、预防措施

过敏性疾病的预防需从“避免致敏暴露、增强机体耐受、早期干预”三方面入手，结合遗传与环境因素，降低过敏发生风险，减少发作频率，具体措施如下：

（一）一级预防：预防健康人群发生过敏

针对无过敏史但有遗传倾向的人群（如父母一方有过敏性疾病），重点通过环境干预与生活方式调整，减少过敏易感因素：

婴幼儿期预防：婴幼儿期是免疫系统发育的关键时期，需避免过度清洁（“卫生假说”提示过度清洁可能减少微生物暴露，增加过敏风险），鼓励适度接触自然环境（如户外活动、接触宠物），但需避免接触明确过敏原（如花粉、尘螨）；母乳喂养至少 6 个月，母乳中的免疫球蛋白可增强婴儿肠道屏障功能，减少食物过敏风险，若无法母乳喂养，可选择低敏配方奶粉（如深度水解蛋白配方奶粉、氨基酸配方奶粉），避免早期摄入牛奶、鸡蛋等易致敏食物（建议牛奶在 1 岁后、鸡蛋在 8 个月后、坚果在 3 岁后逐渐添加）。

环境控制：保持室内空气流通（每日通风 2-3 次，每次 30 分钟），控制室内湿度在 40%-60%（避免尘螨滋生），使用空气净化器（带 HEPA 滤网）减少室内花粉、尘螨浓度；避免室内吸烟（二手烟会刺激呼吸道黏膜，增加哮喘风险），减少使用空气清新剂、杀虫剂等刺激性化学物质。

饮食与生活方式：均衡饮食，增加富含 Omega-3 脂肪酸的食物（如深海鱼、亚麻籽），Omega-3 脂肪酸具有抗炎作用，可能降低过敏风险；规律运动，每周进行 150 分钟中等强度有氧运动（如快走、游泳），增强机体免疫力；避免长期精神紧张（压力会影响免疫调节，增加过敏风险），通过冥想、深呼吸训练缓解压力。

（二）二级预防：预防过敏前期发展为典型过敏

过敏前期（如血清特异性 IgE 升高但无临床症状、特应性皮炎早期）人群，需通过早期干预延缓或阻止疾病进展：

过敏原监测：定期进行过敏原检测（如皮肤点刺试验、血清 sIgE 检测），明确潜在致敏原，提前采取规避措施，如检测发现对尘螨 sIgE 升高，及时使用防螨用品，减少尘螨暴露。

皮肤屏障保护：特应性皮炎早期患者（皮肤干燥、轻微瘙痒）需加强皮肤保湿，每日使用温

和的保湿霜（如含神经酰胺、透明质酸的保湿霜），洗澡后 3 分钟内涂抹，锁住皮肤水分，修复皮肤屏障，减少过敏原穿透皮肤引发炎症；避免使用碱性强的肥皂、沐浴露，减少皮肤刺激。

药物预防：过敏高发期（如花粉季）前 2-4 周，预防性使用抗组胺药（如氯雷他定）或鼻用糖皮质激素（如布地奈德鼻喷剂），可减少过敏症状发作的严重程度，尤其适合过敏性鼻炎患者；昆虫毒液过敏患者在高发季节（如夏季）前，可在医生指导下使用预防性抗组胺药，降低叮咬后过敏反应风险。

（三）三级预防：预防过敏性疾病加重与并发症

针对已确诊过敏性疾病的患者，重点通过规范治疗与管理，预防症状加重、复发及并发症（如哮喘急性发作、过敏性休克）：

长期规范治疗：严格遵医嘱使用药物，不可自行停药或调整剂量，如过敏性哮喘患者需长期吸入糖皮质激素，即使症状缓解也需维持治疗（临床缓解期可减少剂量，但不可停药），避免气道炎症反复；食物过敏患者需终身坚持禁食致敏食物，定期复查（每 6-12 个月评估一次是否可逐渐耐受），不可盲目尝试“脱敏”。

自我管理教育：患者需掌握疾病相关知识，如过敏性休克的早期识别（皮肤瘙痒、呼吸困难、头晕）与应急处理（立即使用肾上腺素笔、拨打急救电话），随身携带急救药物（如肾上腺素笔、抗组胺药），尤其食物过敏、昆虫毒液过敏患者；记录“过敏日记”，详细记录症状发作时间、诱因、用药情况，帮助医生调整治疗方案。

并发症监测：定期进行相关检查，监测并发症，如过敏性哮喘患者每 3-6 个月进行肺功能检查（FEV1/FVC、支气管舒张试验），评估气道功能；特应性皮炎患者定期检查皮肤（观察是否有感染迹象，如脓疱、红肿），避免继发细菌感染（如金黄色葡萄球菌感染）；药物过敏患者使用新药物后，需观察 30 分钟以上，无不适再离开医院，避免延误重症药疹的早期治疗。

七、特殊人群过敏性疾病管理

（一）婴幼儿过敏性疾病管理

婴幼儿免疫系统与器官功能尚未发育完善，过敏症状不典型，管理需兼顾安全性与有效性：疾病特点：婴幼儿过敏以食物过敏（牛奶、鸡蛋为主）、特应性皮炎、过敏性鼻炎多见，食物过敏常表现为湿疹加重、呕吐、腹泻、便血，易被误诊为“消化不良”；过敏性鼻炎多表现为鼻塞、张口呼吸、打鼾，无明显鼻痒、打喷嚏（无法表达），需通过体格检查（鼻黏膜苍白水肿）与过敏原检测确诊。

治疗原则：优先选择局部用药与口服第二代抗组胺药，避免使用全身糖皮质激素（仅在重症时短期使用）；食物过敏以规避致敏食物为主，牛奶过敏者选择深度水解或氨基酸配方奶粉，鸡蛋过敏者可先尝试蛋黄（致敏性低于蛋清），逐渐少量添加；特应性皮炎患儿使用弱效外用糖皮质激素（如氢化可的松乳膏），每日 1-2 次，连续使用不超过 1 周，配合温和保湿霜（每日使用 2-3 次）；过敏性鼻炎患儿使用生理盐水滴鼻（软化鼻痂，改善鼻塞），必要时使用鼻用糖皮质激素（如糠酸莫米松鼻喷雾剂，2 岁以上儿童可用）。

护理要点：穿着纯棉、宽松衣物，避免羊毛、化纤材质；洗澡水温控制在 32-37℃，时间不超过 10 分钟，避免过度清洁；母乳喂养母亲需注意饮食，若婴儿对牛奶过敏，母亲需避免牛奶及含乳食品（观察婴儿症状是否改善）；定期监测生长发育（体重、身高），避免因食物规避导致营养不良，必要时咨询营养师制定个性化饮食方案。

（二）妊娠期与哺乳期女性过敏性疾病管理

妊娠期与哺乳期女性用药需严格评估母婴风险，避免药物对胎儿或婴儿产生不良影响：

治疗原则：优先通过规避过敏原控制症状，如过敏性鼻炎患者避免花粉、尘螨暴露，减少药物使用；必须用药时，选择安全性高的药物，如抗组胺药首选氯雷他定、西替利嗪（FDA 妊

妊娠分级 B 级，对胎儿影响小），避免使用第一代抗组胺药（如氯苯那敏）与新型抗组胺药（如左西替利嗪，安全性数据不足）；糖皮质激素仅在重症时使用，如重症哮喘急性发作，选择吸入性糖皮质激素（如布地奈德），全身用药需在医生评估后使用（权衡利弊）。

哺乳期注意事项：抗组胺药（氯雷他定、西替利嗪）在乳汁中浓度低，可正常使用，不影响母乳喂养；吸入性糖皮质激素（如布地奈德）几乎不进入乳汁，可安全使用；避免使用免疫抑制剂、长效糖皮质激素，减少药物对婴儿的潜在影响；食物过敏母亲无需常规禁食“易致敏食物”（如牛奶、鸡蛋），仅在婴儿出现过敏症状（如湿疹加重、便血）时，尝试禁食并观察症状是否改善。

母婴风险防控：妊娠期过敏性哮喘若控制不佳，可导致胎儿缺氧、早产，需严格将哮喘控制在“临床缓解期”（无喘息、胸闷），定期监测肺功能；避免使用可能引发过敏的药物（如青霉素类），必须使用时需进行皮肤试验，阴性后方可使用；产后需评估婴儿过敏风险（如父母均有过敏史），建议母乳喂养，避免早期添加牛奶、鸡蛋等易致敏食物。

（三）老年人过敏性疾病管理

老年人免疫功能下降、合并基础疾病多（如高血压、糖尿病、冠心病），过敏症状不典型，易漏诊或误诊：

疾病特点：老年人过敏以药物过敏（抗生素、非甾体抗炎药）、呼吸道过敏（尘螨、霉菌）多见，药物过敏常表现为重症药疹（如 Stevens-Johnson 综合征），因皮肤屏障功能差，皮疹易合并感染；呼吸道过敏症状与慢性阻塞性肺疾病（COPD）相似（咳嗽、喘息），需通过肺功能检查（支气管舒张试验）鉴别（过敏性哮喘支气管舒张试验阳性，COPD 阴性）。

治疗原则：用药需综合评估基础疾病，避免药物相互作用，如高血压患者使用抗组胺药时，选择无升压作用的药物（如氯雷他定），避免使用伪麻黄碱（收缩血管，升高血压）；糖尿病患者使用糖皮质激素时，需监测血糖（可能导致血糖升高），必要时调整降糖药剂量；药物过敏患者需终身禁用致敏药物，就医时携带“过敏药物清单”，避免医生开具同类药物。

护理要点：定期清洁室内环境（减少尘螨、霉菌滋生），尤其潮湿季节（如梅雨季），使用除湿机控制湿度 < 60%；穿着宽松、透气衣物，避免皮肤摩擦引发接触性皮炎；定期监测基础疾病（血压、血糖、肺功能），避免过敏诱发基础疾病加重（如哮喘发作诱发冠心病）；家人需协助老年人记录过敏症状与用药情况，避免漏服或错服药物。

（四）免疫缺陷者过敏性疾病管理

免疫缺陷者（如 HIV 感染、化疗患者、长期使用免疫抑制剂者）过敏反应更严重，易合并感染，管理需强化预防与监测：

疾病特点：免疫缺陷者过敏以药物过敏（抗生素、化疗药）、吸入性过敏（尘螨、霉菌）多见，药物过敏易发展为重症药疹（伴肝肾功能损伤），吸入性过敏易诱发重症哮喘（因免疫功能差，炎症难以控制）；过敏症状与感染症状相似（如发热、皮疹），需通过实验室检查（血常规、病原学检测）鉴别。

治疗原则：优先选择安全性高、副作用小的药物，如抗组胺药选择第二代（如依巴斯汀），避免使用免疫抑制剂（如环孢素）；药物过敏患者需在医生监护下使用新药物，首次使用时从小剂量开始，观察 24 小时无不适再逐渐加量；吸入性过敏患者使用吸入性糖皮质激素联合长效支气管扩张剂，定期复查肺功能，避免哮喘急性发作。

感染防控：过敏发作时需监测是否合并感染，如特应性皮炎患者皮肤出现脓疱，需进行细菌培养（排查金黄色葡萄球菌感染），必要时使用抗生素（如莫匹罗星软膏）；重症药疹患者需加强皮肤护理（如使用无菌纱布覆盖破损皮肤），避免继发感染；定期进行免疫功能评估（如 CD4+T 细胞计数），根据免疫状态调整治疗方案，避免过度治疗或治疗不足。

八、过敏性疾病的长期管理与随访

过敏性疾病多为慢性复发性疾病，长期管理的核心是“持续控制症状、减少复发、提升生

活质量”，需建立医患协作模式，通过定期随访动态调整方案，确保治疗的连贯性与针对性。

（一）随访频率与内容

1. 常规随访（症状稳定者）

频率：轻中度过敏性疾病（如间歇性过敏性鼻炎、偶发荨麻疹）患者，每 3-6 个月随访 1 次；慢性持续性疾病（如慢性过敏性哮喘、重度特应性皮炎）患者，每 1-2 个月随访 1 次。

内容：评估症状控制情况，如过敏性鼻炎患者采用“视觉模拟评分（VAS）”评估鼻痒、鼻塞等症状（0 分为无症状，10 分为最严重），过敏性哮喘患者通过肺功能检查（FEV1/FVC）评估气道功能；复核过敏原规避措施的执行情况（如是否定期清洗防螨用品、是否误食致敏食物），针对不足处给予指导；检查药物使用的规范性（如吸入性糖皮质激素的正确操作、抗组胺药的服用剂量），纠正错误用药方式；监测药物副作用，如长期使用外用糖皮质激素者检查皮肤是否出现萎缩、毛细血管扩张，使用全身糖皮质激素者监测血糖、血压。

2. 强化随访（症状不稳定或调整治疗方案者）

频率：新确诊患者、近期调整药物剂量者（如增加抗组胺药剂量、更换糖皮质激素类型），或症状加重者（如哮喘发作频率增加、荨麻疹持续超过 1 周），每 2-4 周随访 1 次，直至症状稳定。

内容：除常规随访项目外，需重点评估治疗效果，如调整抗组胺药后皮肤瘙痒是否缓解、更换哮喘用药后喘息是否减少；必要时复查过敏原检测（如血清 sIgE），判断是否出现新的致敏原或原有致敏原的过敏程度变化；对于食物过敏患者，评估是否达到“脱敏”条件（如牛奶过敏儿童年龄增长后，是否可尝试少量添加），在医生监护下进行食物激发试验；监测并发症，如特应性皮炎患者是否合并皮肤感染（如脓疱疮）、过敏性哮喘患者是否出现气道重塑（通过胸部 CT 或肺功能检查判断）。

3. 年度全面评估

每年进行 1 次全面检查，包括：血常规（监测嗜酸性粒细胞计数，评估炎症程度）、总 IgE 与特异性 IgE 检测（判断过敏状态变化）、肺功能检查（哮喘患者必查）、皮肤状况评估（特应性皮炎患者）；

针对长期用药患者，进行肝肾功能检查（如长期使用抗组胺药或免疫抑制剂者）、骨密度检测（长期使用全身糖皮质激素者，预防骨质疏松）；

评估患者生活质量，采用“过敏性疾病生活质量量表（AQLQ）”等工具，了解症状对睡眠、工作、社交的影响，调整管理目标（如改善睡眠质量、提升运动耐量）。

（二）长期管理中的患者教育

每次随访需结合患者实际情况强化教育，提升自我管理能力，重点包括：

过敏原识别与规避技巧：指导患者通过“日记法”记录日常接触物与症状的关联（如记录每日饮食、接触的衣物材质、环境变化，以及是否出现瘙痒、喘息），辅助明确潜在致敏原；教授具体规避方法，如对霉菌过敏者如何检查室内潮湿区域（如卫生间、衣柜）、如何使用除湿机控制湿度，对食物过敏者如何解读食品成分表（识别隐藏的致敏成分，如“乳清蛋白”提示含牛奶成分）。

急救技能培训：针对过敏性休克高危人群（如食物过敏、昆虫毒液过敏、药物过敏患者），培训肾上腺素笔的正确使用方法（如注射部位选择大腿外侧、注射后需按摩 10 秒），告知急救流程（注射肾上腺素后立即拨打急救电话，等待期间保持患者平卧、头偏向一侧）；让患者熟悉过敏性休克的早期信号（如皮肤瘙痒加重、声音嘶哑、头晕），避免延误抢救时机。

药物使用细节：详细讲解药物的作用机制、正确用法用量及注意事项，如吸入性糖皮质激素需在吸入后漱口（减少口腔念珠菌感染风险），抗组胺药需规律服用（而非仅在症状发作时服用，尤其慢性荨麻疹患者）；告知患者药物副作用的应对方法，如服用第二代抗组胺药出

现轻微嗜睡时，可调整服药时间（如改为睡前服用），外用糖皮质激素引发皮肤干燥时，需加强保湿。

生活方式调整指导：根据疾病类型给出个性化建议，如特应性皮炎患者需避免频繁洗澡、选择温和的保湿产品，过敏性哮喘患者需避免剧烈运动（可选择游泳等低强度运动）、预防呼吸道感染（如接种流感疫苗）；指导患者如何在过敏高发期（如花粉季）安排生活，如调整外出时间（避开花粉浓度高峰时段，如早晨 6-10 点）、做好防护措施（佩戴口罩、眼镜）。

（三）多学科协作管理模式

对于复杂过敏性疾病患者（如合并多种过敏类型、或伴随基础疾病），需建立多学科协作（MDT）团队，成员包括变态反应科医生、呼吸科医生、皮肤科医生、营养师、药师及心理咨询师，共同制定管理方案：

营养师参与：针对食物过敏患者，制定均衡的替代饮食方案（如牛奶过敏儿童需选择富含钙的替代食物，如豆制品、绿叶菜），避免因禁食致敏食物导致营养不良；指导特应性皮炎患者通过饮食调整减轻炎症（如减少高糖、高脂食物摄入，增加富含维生素 C、维生素 E 的食物）。

呼吸科医生参与：协助管理过敏性哮喘患者，评估肺功能变化，调整气道用药方案（如联合使用支气管扩张剂与抗炎药物），指导患者进行呼吸训练（如腹式呼吸、缩唇呼吸），改善通气功能；排查是否合并慢性阻塞性肺疾病等其他呼吸道疾病，避免误诊。

皮肤科医生参与：针对严重皮肤过敏性疾病（如重症特应性皮炎、Stevens-Johnson 综合征），制定皮肤护理方案（如创面处理、感染防控），调整外用药物（如选择合适强度的糖皮质激素、使用免疫抑制剂软膏）；监测皮肤并发症（如皮肤感染、色素沉着），及时干预。

心理咨询师参与：关注长期受过敏症状困扰患者的心理状态（如因慢性瘙痒导致失眠、焦虑，因食物过敏导致社交回避），通过认知行为疗法、放松训练等方式缓解负面情绪；帮助患者建立积极的疾病认知，减少对疾病的恐惧（如告知过敏性哮喘通过规范治疗可正常生活）。

九、总结与展望

过敏性疾病是一类与免疫异常密切相关的慢性疾病，其管理需贯穿“预防 - 治疗 - 长期随访”全过程，核心在于明确过敏原并规避、合理使用对症药物控制炎症、强化特殊人群的个体化管理，同时通过患者教育提升自我管理能力。当前临床实践中，仍存在过敏原检测精准度不足（如非 IgE 介导型过敏缺乏有效检测手段）、部分重症患者治疗方案有限（如难治性特应性皮炎）等问题，需进一步探索创新技术与疗法。

随着医学技术的发展，过敏性疾病的诊疗正朝着“精准化、靶向化”方向迈进。例如，过敏原特异性免疫治疗（AIT）为部分患者提供了“根治”可能，通过逐渐增加患者对致敏原的接触剂量，诱导免疫系统耐受（如针对尘螨、花粉过敏的皮下注射或舌下含服免疫治疗），可显著减少过敏发作频率与严重程度；生物制剂（如抗 IgE 抗体、抗 IL-4 受体抗体）为重症患者带来新选择，如抗 IgE 抗体可用于治疗中重度过敏性哮喘、慢性自发性荨麻疹，通过靶向抑制 IgE 介导的免疫反应，快速控制症状且副作用小。

未来，随着对过敏机制研究的深入（如肠道菌群与过敏的关联、遗传因素对过敏的影响），以及人工智能技术在过敏原检测、治疗方案制定中的应用（如通过 AI 分析患者病史与检查结果，精准推荐过敏原规避措施与用药方案），过敏性疾病的管理将更加科学、高效，最终实现“减少过敏发生、控制症状复发、提升患者生活质量”的目标。